# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77087
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-01-09 10:04:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : TERESA MENDEZ GUTIERREZ | | | RUN | : 7.008.528-3 |
| F.Nac | : 10-05-1940 | Edad | : 83 AÑOS, 7 MESES | Género | : Femenino |
| Dirección | : | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : SIN INFORMACION | Teléfono | : 0 | | |
| Fecha Ingreso | : 2024-01-05 | Fecha Egreso | : 2024-01-09 10:04:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : DOMICILIO | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R07.4-DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Angina de Pecho
- Hematoma sin golpe en ESD
- Hipertensión Arterial
-Gastritis crónica
-Coxartrosis
-Gonartrosis
-Dislipidemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I20-ANGINA DE PECHO. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Acorde a relato de familiar, paciente es derivada desde TMT (Durante valoración de control secundario artrosis), debido a dolor torácico opresivo recurrente, localizado, de minutos de duración (no precisado, al menos mas de 20). Familiar destaca que ha tenido episodios similares desde hace 2 semanas aproximadamente, con gatillante emocional claro: existe un franco apego emocional entre paciente (madre) y familiar (hija), generando aparentes crisis de pánico al separarse (dolor torácico opresivo, sensación de ahogo y muerte inminente, crisis de llanto, labilidad emocional franca, temblor distal). Durante estancia en servicio de urgencias se toman troponinas control, iniciales reportadas en 147, control en 159, por lo que se presenta caso en HLH donde se considera realización de proceso invasivo el cual es llevado a cabo el 05/01/24, con coronariografía que reporta negativa para lesiones obstructivas, retornando a SU HSC. Durante este periodo, además, paciente inicia con presiones arteriales elevadas por lo que se decide iniciar con BIC de nitroglicerina (incluso antes de ir a HLH), sin tomar terapia antihipertensiva crónica. Se retoma enalapril 10mg vo + carvedilol 6.25 mg vo en dosis única previo a ingreso a servicio de medicina, llegando con presión arterial registada de 180/80 a pesar de BIC nitroglicerina a razón de 40ucg/h, se disminuye a 20. Presenta episodio de nauseas, sin vómitos, aunado a somnolencia, por lo que se suspende BIC de nitroglicerina, se toma nueva presión arterial manual 100/70mmHg. Se deja en trendelemburg, se pasa bolo ringer 250cc ev, recuperando presión arterial 150/80mmHg. En vista de condición actual, procedimiento invasivo reciente y mal manejo de presiones arteriales, se decide ingreso a servicio. Ex físico: Piel: Cambios y signos propios de la edad. Buen llenado capilar. CP: Torax simétrico, normoexpansible, RSRSPS SA RSCSRSRS SS NG Abd: RHA, sin megalias. BDI Neuropsicológico: Desorientada en tiempo, orientada en espacio y persona. Consciente, sin signos de focalización o irritación meníngea. Labil emocionalmente, se descompensa con facilidad en ausencia de familiar responsable (hija), ansiosa, temblor distal leve.

Coronariografia 5/01/24.: Arterias Coronaria Sin Lesiones Obstructivas . -Refiere sentirse bien, con leve dolor en brazo derecho.
Eco doppler veneoso de ESD: Exámenes negativo para trombosis Venosa Profunda. -no hay signos sugerentes

de tromboflebitis.

Hemodinamia estable, hidratada, normotensa, normocardica, yugulares planas, torax expansible mp presente sin agregados, esd con extenso hemetoma endurado, con cambio de temperatura , abdomen plano blando rha presente no doleroso, eeii sin edema, neurológico vigil orientad glagsow 15 ptos

## PLAN DE MANEJO:

Hospitalizar En HODOM
Seguimiento Médico Y De Enfermería Por 7 Dias
Reposo Relativo
Regimen Liviano Hiposodico Para Diabeticos
Ic Cardiologia
Frio Local
Paracetamol 1gr Ev Cada 8hrs Sos Dolor
Medicamento Indicacion
Ácido Acetilsalicilico 100 Dia Vo
Carvedilol 6,25 Mg Cada 12 Hrs Vo
Enalapril 10 Mg Cada 12 Hrs Vo
Amlodipino 10 Mg 1/2 Dia Vo
Control SOS Urgencias

## INDICACIONES AL ALTA

1. Hospitalizar En HODOM
2. Seguimiento Médico Y De Enfermería Por 7 Dias
3. Reposo Relativo
4. Regimen Liviano Hiposodico Para Diabeticos
5. Ic Cardiologia
6. Frio Local
7. Paracetamol 1gr Ev Cada 8hrs Sos Dolor
8. Medicamento Indicacion
9. Ácido Acetilsalicilico 100 Dia Vo
10. Carvedilol 6,25 Mg Cada 12 Hrs Vo
11. Enalapril 10 Mg Cada 12 Hrs Vo
12. Amlodipino 10 Mg 1/2 Dia Vo
13. Control SOS Urgencias

## EXÁMENES Y RESULTADOS

Glicemia : 94 mg/dl 74 - 106
Creatinina : 0,60 mg/dl 0,52 - 1,04
Clearence Calculado(MDRD) : 95,47
Proteina C Reactiva : 6,8
Sodio ( Na ) : 143,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio ( K ) : 3,70 mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro ( Cl ) : 107,00
leucocitos : 4,70 mil/ul 3,80 - 11,80
Recuento Hematies : 3,40 * Mill/ul 4,00 - 5,20
Hematocrito : 32,3 o/o 31,2 - 41,9
Hemoglobina : 10,9 g/dl 10,9 - 14,3
V.C.M. : 95,1 fl 75,5 - 95,3
H.C.M. : 32,2 ug 24,7 - 32,8
C.H.C.M. : 33,8 g/dL 32,3 - 35,6
R.D.W. : 13,7 o/o 12,3 - 17,7
Plaquetas : 202

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO

26251544-3